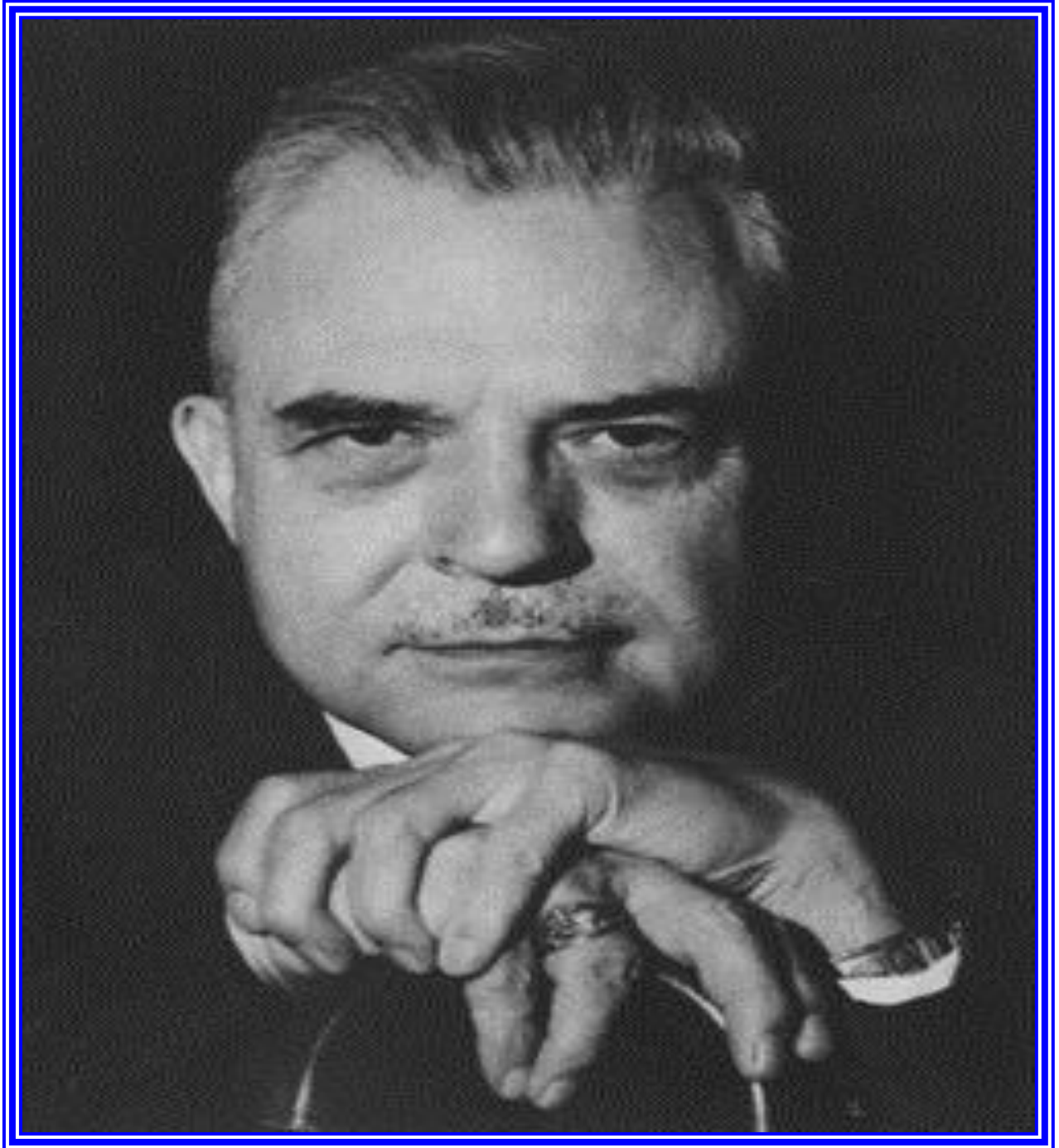


HIPNOSIS NATURALISTA DE

MILTON ERICKSON



INDICE

I Biografía del autor y definición de hipnosis naturalista

1.1. Biografía de Milton Ericsson

1.2. Antecedentes de hipnosis naturalista.

1.3. Hipnosis en la actualidad

1.4. Definición de Hipnosis

1.5. Definición de Hipnosis Naturalista Ericksoniano

II Aspectos conceptuales y teóricos de la hipnosis

2.1. Aspectos conceptuales

2.1.1. Sugestión

2.1.2. Estado subjetivo de experiencia

2.1.3. Atención focalizada y absorción en el proceso

2.1.4. Disociación.

2.1.5. Lógica del trance

2.2. Aspectos teóricos sobre la Hipnosis

2.2.1. Teorías de Disociación y Neodisociación

2.2.2. Teoría de la Construcción social o Teoría del rol

2.2.3. Hipótesis de Nicolás Spanos

**2.2.4. Hipnosis como proceso condicionado
induciendo a dormir**

2.2.5. Teoría de la hiper sugestibilidad

2.2.6. Teoría Informacional

2.2.7. Estado de histeria

2.2.8. Investigación de la hipnosis

III Características del estado hipnótico

3.1. Características del estado hipnótico

3.1.1. Aumento de la sugestionabilidad

**3.1.2. Aumento de la capacidad de imaginería
mental**

3.1.3. Aumento de la implicación emocional

**3.1.4. Focalización de la atención a una situación
restringida**

**3.1.5. Distorsión de las variables psicológicas de
espacio y tiempo**

3.1.6. Automaticidad del comportamiento.

**3.1.7. Disminución de la capacidad de análisis
lógico-racional**

3.1.8. Sensación de relajación profunda

3.1.9. Alteraciones psicofisiológicas

3.2. Componentes del trance hipnótico

3.2.1. Seguridad

3.2.2. Relajación Psicofísica.

3.2.3. Concentración relajada.

3.2.4. Receptividad

3.2.5. Recuerdo

3.2.6. Hipersugestibilidad

3.2.8. Consciencia paralela

3.2.7. Refuerzo.

3.2.9. Olvido selectivo

3.2.10. Actitud Mental Positiva

IV Métodos, estados y utilidades en la hipnosis

4.1. Métodos de la hipnosis ericksoniana

4.1.1. Método de inducción oral.

4.1.2. Métodos de fijación de la mirada

4.1.3. Método de la catalepsia

4.1.4. Método de la rigidez del brazo

4.1.5. Método de la expectación

4.1.6. Método del “engaño”

4.2. Estados en la hipnosis

4.2.1. Reacciones en el hipnotizado.

4.3. Utilidades de la hipnosis.

4.3.1. Medicina.

4.3.2. Psicología

4.3.3. Educación y enseñanza

4.3.4. Economía, empresa, ventas

4.3.5. Política y comunicación social

4.3.6. Deporte.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo está enfocado en resaltar la importancia del tratamiento por medio de Hipnosis es el procedimiento terapéutico que está llamado a ocupar un lugar prominente entre las técnicas utilizables para mejorar la salud mental de los individuos. Puede ser considerada como una de las técnicas más antiguas que se conocen para provocar cambios en los procesos cognitivos, psicofisiológicos, perceptuales y conductuales.

Si echamos mano de nuestros conocimientos antropológicos, observaremos que en todas las culturas, de una u otra forma, los médicos, sacerdotes, han utilizado los efectos de las sugerencias para "adornar", "destacar" o "potenciar" la eficacia de fármacos y brebajes u otros procedimientos físicos o psicológicos de intervención. Estas sugerencias consistían en ideas, que comunicadas en debida forma a los pacientes, les hacía esperar los efectos más benéficos de los tratamientos. Mediante palabras, gestos, señales subvocales u otros medios de comunicación cualesquiera, explícita o implícitamente la instrucción.

En nuestra cultura occidental, la "sugestión hipnótica" cobra carta de naturaleza de la mano de Franz Anton Mesmer, al que siguieron otros muchos estudiosos, investigadores y clínicos quienes fueron estableciendo progresivamente las bases científicas de la actual hipnosis clínica y experimental.

Una de las definiciones de la hipnosis más aceptadas por la comunidad científica corresponde a la que en 1955 la Comisión de la "British Medical Association"

apuntó: "Un estado pasajero de la atención modificada en el sujeto, estado que puede ser producido por otra persona y en el que diversos fenómenos pueden aparecer espontáneamente o en respuesta a los estímulos verbales u otros. Estos fenómenos comprenden un cambio en la conciencia y la memoria, una susceptibilidad agudizada a la sugestión y a la aparición en el sujeto de respuestas y de ideas que no le son familiares en su estado anímico habitual. Fenómenos como la anestesia, parálisis, rigidez muscular y modificaciones vasomotoras pueden ser producidas y suprimidas bajo hipnosis". Esta organización, en 1962, determinó aconsejar la utilización de la hipnosis en el tratamiento de distintas neurosis, dolor crónico, así como su aplicación en los ámbitos de la cirugía y obstetricia (Kroger, 1963), lo que contrasta con nuestro asombro al comprobar que nuestra Seguridad Social no admite entre sus tratamientos el empleo de la misma.

La hipnosis no presenta contraindicaciones y es empleada por profesionales acreditados en Psiquiatría,

Medicina, y especialmente, en Psicología, siendo las características del estado hipnótico cruciales para la modificación de comportamientos inadaptados y pensamientos irracionales, la integración emocional y para la intervención sobre componentes psicofisiológicos de la conducta.

La hipnosis se emplea también para reestructurar los pensamientos irracionales presentes en los cuadros depresivos (la visión negativa del mundo, de uno mismo y del futuro); existen procedimientos hipnóticos para fortalecer nuestra autoestima; la hipnosis también se emplea para superar distintas adicciones, especialmente el tabaco; el dolor crónico, puede aliviarse mediante el empleo de procedimientos hipnosuggestivos. En fin, son numerosos los trastornos psicológicos en los que el empleo de estas estrategias puede ser de indudable interés para la salud del paciente.

I BIOGRAFÍA DEL AUTOR Y DEFINICIÓN DE HIPNOSIS NATURALISTA DE ERICKSON

1.1. BIOGRAFÍA DE MILTON ERICKSON.

Un 5 de Diciembre de 1901, en una humilde casa de un pueblo minero conocido por los lugareños como Aurum, en las Montañas de Sierra Nevada, Phoenix, Arizona; Estados Unidos, nace el segundo de los once hijos de una familia minera. Este niño, bautizado como Milton Hyland Erickson, viajó con sus padres en un carromato hasta Lowell, Wisconsin, donde pasó su infancia y su adolescencia, dedicándose la familia a la agricultura. Milton desde pequeño presentó algunas deficiencias: daltonismo, era sordo a los tonos e incapaz de reconocer o producir ritmos musicales, y evidenció algún grado de dislexia. Esos problemas no fueron detectados y al parecer no dificultaron su aprendizaje escolar. En 1919 se graduó de la secundaria, y para esa fecha había publicado un artículo en una revista de

agricultura y era un destacado atleta. En Agosto de ese año enfermó de poliomelitis, y requirió un año para recuperarse. Ingresó a la Escuela de Medicina en 1920, y en 1928 recibió su grado médico y su magíster en psicología.

La práctica médica y psiquiátrica la realizó en el Hospital de Colorado, y en los próximos veinte años de su carrera ocupó destacadas posiciones en distintos hospitales y universidades norteamericanas. A finales de la década de los '30 ya tenía fama de ser un hábil observador. En 1935 finaliza su primer matrimonio y en 1936 se casa con Elizabeth, quien sería su compañera y colaboradora de por vida. En 1948, por motivos de salud se trasladó a Phoenix, Arizona, donde residió hasta la fecha de su muerte, el 25 de Marzo de 1980. Un 9 de Mayo de 1904, en el seno de una familia de intelectuales ingleses, nace el tercero de tres hermanos, Gregory Bateson. Su padre, William Bateson, biólogo, lamarkiano en sus inicios, se dedicó al estudio de la evolución de las especies, y

luego a investigar las leyes que gobiernan las formas orgánicas. La mayor parte de su carrera la ocupó en el desarrollo de una nueva ciencia, que bautizó como "genética." Llamó Gregory a su tercer hijo, en honor del desconocido monje austriaco, Gregor Mendel, descubierto por él y su colega holandés de Vries.

Era inevitable, entonces, que Gregory estudiara biología en Cambridge. Cuando tenía 21 años, un millonario le propone que lo acompañe en un viaje a Las Galápagos. En ese viaje a esas históricas islas (recuérdese a Darwin), más se interesó por las diferentes culturas que por la biología; y a su regreso a casa sabía que quería dedicarse a la antropología.

En 1927, nuestro joven antropólogo se traslada a Nueva Guinea para realizar su primer trabajo de campo. Posteriormente viaja a Sidney, y en 1929 conoce a otros dos antropólogos, Fortune y Mead. En 1932 regresa a Nueva Guinea a realizar su trabajo de doctorado, en donde vuelve a encontrarse con Mead y su esposo (Fortune). Al regresar a la vida

occidental, Gregory y Margaret Mead estaban enamorados, contrayendo matrimonio en 1935.

1.2. ANTECEDENTES DE HIPNOSIS NATURALISTA.

A lo largo de los siglos han surgido antiguos procedimientos de la magia, religión y, posteriormente, de la ciencia. Los antecedentes de la relajación e hipnosis contemporánea aparecieron, por primera vez, hace 5000 años en los rituales mágicos de Egipto e India. El documento escrito más antiguo, del que se dispone, que nos narra cómo la hipnosis era utilizada en tiempos remotos es El Papiro de Harris. También llamado Papiro Mágico o Papiro de Ebers. Escrito en lengua egipcia hierática cerca del 3.000 antes de Cristo y traducido por Chabas en 1.860. Describe cómo los adivinos egipcios empleaban métodos hipnóticos muy parecidos a los practicados actualmente.

Rituales similares persistieron en los tiempos de los griegos y de los romanos, la dominación celta y cristiana de Europa, e incluso hasta el siglo XVIII. La

base teórica de muchos de estos rituales se fundamentaba en la idea de que un espíritu vital, flujo o fluido magnético podía fluir de una persona a otra. Las técnicas incluían la imposición de manos, el enfoque de la atención, la utilización de cánticos y encantamientos, e incluso imanes para dirigir el flujo del espíritu vital.

Mesmer con su método naturalista fue el precursor directo de la hipnosis contemporánea. Médico, nacido en Viena. Es el fundador de la doctrina del magnetismo animal, también conocida con el nombre de Mesmerismo.

Mesmer creía que los cuerpos vivientes poseen un fluido magnético que, cuando se desequilibra, produce miseria y enfermedad. Además, transferir "fluido" a los pacientes necesitados induce en un primer momento crisis o convulsiones y, después, hace que los fluidos se equilibren, curando a los pacientes de diversas enfermedades. Mesmer habló de la magnetización de objetos inanimados, como la madera, el metal, el agua... de la influencia de los

planetas en el ser humano y de otros muchos fenómenos extraños. Mesmer hizo especial hincapié en la importancia de sus "pases" (caricias corporales apenas perceptibles) con el objetivo de magnetizar al paciente; las curas que realizaba iban seguidas de crisis y convulsiones, "efecto secundario curativo" de sus pases e inducciones.

El mesmerismo no es el producto del magnetismo animal ni de cualquier otro, sino de la mera imaginación. El mesmerismo tuvo gran influencia en su época. En el siglo XIX Esdaile, entre otros, popularizó las propiedades anestésicas del magnetismo, más que las "crisis" mesmerianas.

Sin embargo la teoría del "magnetismo animal" fue totalmente rechazada por el Abad de Faria (1819) y, posteriormente, por James Braid (1843). Braid, Médico inglés. Usó el mesmerismo. Se dedicó especialmente al estudio de las enfermedades nerviosas en su relación con los fenómenos del magnetismo animal. En 1841 descubrió que la

persistencia de la mirada hacia un objeto brillante, producía un sueño particular.

Acuñó los términos de “hipnosis” e “hipnotismo” del griego hypnos que significa sueño; pero las palabras hipnosis e hipnotismo habían ganado una gran aceptación general. Braid descubrió que era posible inducir la hipnosis sin emplear una técnica formal para ello.

Aunque las teorías de Mesmer se descartaron rápidamente, algunos médicos quedaron muy impresionados por sus resultados. Dos cirujanos ingleses, Eliotson y Esdaile informaron de numerosas intervenciones quirúrgicas importantes realizadas bajo la hipnosis sin anestésico. Según la teoría de James Braid, fijar deliberadamente la atención en un estímulo único, continuo y monótono evoca un sueño nervioso especial o estupor, estado que denominó como se indicó en un par de líneas antes como neurohipnotismo o hipnosis.

Braid, introducido al "mesmerismo" por Lafontaine, publicó en 1843 su libro titulado The Rationale of

Nervous Sleep in relation with Animal Magnetism. En pocos años abandonó explicaciones fisiológicas centrándose en aspectos de índole mental para explicar la hipnosis (imaginación y sugestión). La idea de "inhibición neural" que exploró inicialmente fue recuperada por Ivan Pavlov (padre del conductismo clásico), desarrollando su concepto de la fisiología del sueño (como una inhibición cortical progresiva, que resultó bastante precisa).

Durante los años 1890 y 1900, el neurofisiólogo berlinés Oscar Vogt desarrolló un método de hipnosis, que es un antecedente de los métodos no autoritarios. En vez de ordenar las instrucciones directamente, él insinuaba amablemente lo que quería que hiciera o percibiera el paciente. Además presentó un método con pasos sucesivos, el “método de fraccionamiento”, en el que se podía hipnotizar al paciente durante unos pocos minutos y después se le despertaba. Finalmente, Vogt realizó la importante observación de que algunos de sus pacientes de hipnosis eran capaces de inducir sus

proprios estados, semejantes a la hipnosis (Schultz y Luthe, 1959) y que estos estados, cuando se evocaban unas pocas veces al día, parecían tener un valor terapéutico. Estas ideas de Vogt fueron recogidas para el desarrollo del "Entrenamiento Autógeno" por J.H. Schultz, además de ser las primeras observaciones que se realizaban sobre el método de "autohipnosis".

Durante los últimos años del siglo XVIII se produjo gran polémica y controversia entre dos escuelas de hipnosis representadas por Charcot en la de Saltpêtriére y Bernheim en la Universidad de Nancy. Bernheim argüía que la hipnosis era el resultado de la sugestión y la imaginación, de características psicológicas. Bernheim introdujo el concepto de profundidad de hipnosis (ligero, moderado o profundo). Charcot, por su parte, desarrolló una teoría patológica sugiriendo que la hipnosis era producto de la histeria, siendo ambas consecuencia de un sistema nervioso enfermo. En 1884 y 1885, Charcot logró reproducir "artificialmente" las

parálisis no orgánicas mediante el uso de la hipnosis. Asimismo logró resultados en la recuperación de memorias olvidadas por medio de la hipnosis.

Charcot fue maestro de Sigmund Freud y sus ideas influenciaron poderosamente al inventor del psicoanálisis. Freud fue un entusiasta de la hipnosis, pero mal hipnotizador (estilo de inducción simple, seco y autoritario). En 1889 cambió de perspectiva, abandonando las ideas de Charcot y reconsiderando las que procedían de la Escuela de Nancy, más centradas en la sugestión, y comenzó a trabajar sobre sus ideas respecto a lo beneficioso de recuperar recuerdos reprimidos de los sujetos mediante hipnosis. Finalmente Freud rechazó la hipnosis como método terapéutico, aduciendo la necesidad por los pacientes de ser plenamente conscientes de sus elaboraciones mentales, desarrollando el psicoanálisis.

El uso de la hipnosis languideció hasta hace poco, excepto por el trabajo, relativamente poco conocido, de Clark Hull en los años treinta. Su análisis en

1933 sobre la investigación científica en el campo de la hipnosis (Hypnosis and Suggestibility) todavía es considerado como un clásico.

1.3. HIPNOSIS EN LA ACTUALIDAD

Ciertos acontecimientos precipitaron el renacimiento del hipnotismo; la Segunda Guerra Mundial fue uno de ellos. Los psiquiatras militares recurrieron al hipnotismo para acortar y reforzar el tratamiento de ciertas fobias y otras neurosis.

En Rusia y en Estados Unidos se utiliza en odontología, etc.

Es sobre todo, a partir de mediados de siglo cuando se vuelve con fuerza a las investigaciones sobre la hipnosis y se le va reconociendo su valor como importante instrumento terapéutico.

Erickson M. (1901-1980) introduce nuevos conceptos sobre la hipnosis. Desarrolla la hipótesis naturalista, concibiendo el estado hipnótico como una conducta que se presenta en el sujeto de modo natural; implementa nuevas técnicas de inducción y

profundización y orienta la terapia desde el enfoque de utilización de los recursos del paciente y la sugestión indirecta.

En 1955 el Parlamento inglés prohibía a los titiriteros transformar en un número de circo, que no deja de tener cierto peligro, un método terapéutico cuyo alcance es aún desconocido; pero del que ya se conocen saludables aplicaciones. En este mismo año la British Medical Association aprueba el tratamiento con hipnosis en odontología y obstetricia.

En 1958 la American Medical Association reconoce oficialmente el valor terapéutico del hipnotismo el Council of Medical Health of American Medical Association recomienda la inclusión de la Hipnosis en los programas de estudios de las Facultades de Medicina.

En 1959 se publica la primera escala para medir la susceptibilidad a la hipnosis y la publica la Universidad de Stanford.

En 1962 la Universidad de Harvard publica a su vez otra escala para la medida de la susceptibilidad a la hipnosis.

En 1991 el Gobierno de Israel prohíbe la hipnosis como espectáculo público.

En 1992 se celebra el XII Congreso Internacional de Hipnosis en Jerusalén.

Hoy existen en todo el mundo civilizado asociaciones científicas cuya finalidad es la formación, el desarrollo, la enseñanza y la aplicación de la hipnosis como una técnica más dentro del ámbito de la medicina, psiquiatría y la psicología, es decir, dentro del ámbito completo de todo lo relativo al hombre.

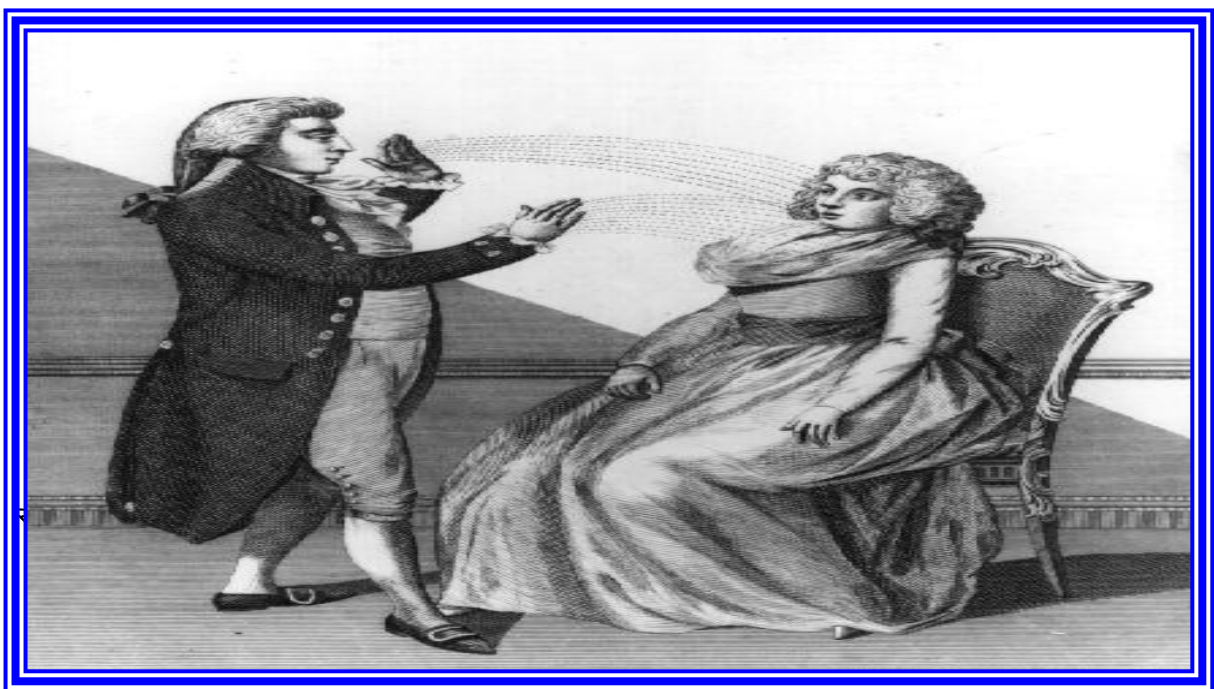
Además, la hipnosis ha entrado como una materia de pleno derecho en el ámbito científico por la puerta principal, es decir, formando parte del corpus teórico académico de muchos profesionales de las Ciencias Sociales, del Comportamiento y de la Salud.

1.4. DEFINICIÓN DE HIPNOSIS.

El nombre moderno de "hipnosis" se relaciona con el médico inglés James Braid, quién en 1840 concibió la hipnosis como un "sueño nervioso". Definió a hipnosis como un proceso de disociación o amnesia reversible que da origen a un estado de doble conciencia. Fue Braid que también acuñó el término genérico "Psicofisiología" para simbolizar las acciones reciprocas de la mente y el cuerpo".

Las posteriores teorías fueron desarrolladas en el siglo XIX. Pavlov explicaba el trance como un "estado de sueño incompleto", resultante de las sugerencias hipnóticas. Suponía que era una condición neurofisiológica.

HIPNOSIS



1.5. DEFINICIÓN DE HIPNOSIS NATURALISTA ERICKSONIANO.

Su enfoque abarca tanto la variedad formal (Técnica) como la variedad naturalista (herramientas para un proceso) debido a que utiliza los propios procesos mentales y conducta del sujeto. Lo naturalista comprende un proceso entre la estabilidad cambio tanto individual y/o familiar que está inserto en la historia experiencia biográfica, donde lo terapéutico es una evocación de recursos inconscientes aprendidos.

La Hipnosis Ericksoniana es concebida como un modelo de comunicación. Milton Erickson incorporó técnicas hipnóticas como parte de un estilo de comunicación general y de comunicación terapéutica en particular, eliminando la formalidad de la hipnosis clásica, de modo que se llegó a hablar de "hipnoterapia sin trance".

Es por ello que su creador, Milton Erickson, la utilizó con gran éxito ya que es más permisiva, es decir le da los elementos al paciente y éste va tomando sus

propias decisiones, rutas y caminos para llegar a una interpretación de la realidad que le resulta más lógica dentro de su estructura mental. Por esto mismo es que es funcional aún con estados de trance ligeros. Es muy utilizada por los modernos terapeutas ya que desmitifica el hecho de tener que "dormir" o "perderse" para poder lograr un cambio en los hábitos o en la forma de percibir los problemas. Está más ligada a nuestro modo actual de vida y es en general más aceptada por los pacientes de nuestra clínica, porque hoy en día a la gente le cuesta más trabajo "dejarse llevar" por miedos infundados que no tenían en épocas pasadas.

II ASPECTOS CONCEPTUALES Y TEÓRICOS DE LA HIPNOSIS

2.1. ASPECTOS CONCEPTUALES

2.1.1. SUGESTIÓN

La sugestibilidad se define como apertura para aceptar y responder a ideas e informaciones nuevas. A medida que se transmite una determinada información, dependiendo de su valor intrínseco

(afectivo, cognitivo, evaluativo, etc.), puede alterarse la percepción y la conducta de una persona en una o varias áreas de su experiencia vital. Dicha influencia puede facilitarse si el receptor está abierto a nuevas ideas y experiencias. Esa apertura en el paciente es constitutiva de éxito en la aplicación de una técnica de hipnosis.

De todos es conocido el extraordinario efecto que puede producirse mediante mensajes sugeridos a otra persona con arreglo a unos determinados patrones verbales, no-verbales, temporales, circunstanciales, arquetípicos y relacionales. La capacidad de influir sobre los demás (¿podría incluso considerarse como adaptativa desde un punto de vista filogenético?), o de ser influidos por otros, se corresponde con una cualidad existente en nuestro cerebro de procesar de forma automática (o inconsciente) determinados mensajes cargados de información (o no) significativa, sin mediar análisis crítico (en apariencia). En la experiencia de la sugestión se basan tratados de oratoria, marketing

publicitario, el efecto placebo, influencia de masas, teorías de la comunicación, etc. En los procesos hipnóticos la capacidad de hipersugestionabilidad en el paciente queda puesta en evidencia.

Las sugerencias para incitar a la calma y la tranquilidad y despreocupación por la enfermedad ha sido una constante histórica en el discurrir de la medicina, sugerencias que emitían los correspondientes profesionales de la salud de cada momento histórico. El objetivo último era la reducción del miedo, la ansiedad y la preocupación del enfermo.

La sugestión se configura, desde todos los puntos de vista, como una técnica relevante en la consulta del psicólogo; nuestra capacidad de influir positivamente sobre nuestros pacientes es decisiva. Una sugerencia, una afirmación sugestiva, puede modificar una conducta, una emoción o un pensamiento. O incitar al paciente a que lo haga por sí mismo o a que disponga lo necesario para resolver sus problemas. La hipnosis, al margen de toda

confusión historicista, constituye un procedimiento validado de modificación de conducta, basada en la sugestión.

Para Yapko (1990) y Erickson (1980) la sugestión es central en el proceso hipnótico. Erickson la define como "un estado de sugestionabilidad artificialmente reforzado, que recuerda sin serlo al sueño, en el que puede producirse una disociación normal..... la hipnosis es esencialmente un estado de receptividad a ideas y a la apreciación de sus valores inherentes y significativos". Erickson, además, utilizaba procedimientos indirectos, con recurso a las propias historias del paciente para realizar las inducciones, fundamentalmente de contenido verbal significativo. Yapko considera a la hipnosis como un "proceso" en el que el hipnólogo ofrece "sugestiones" al sujeto. El proceso se enmarca en un estado de "hipersugestionabilidad", en el cual el sujeto muestra una "sensibilidad pasiva a la sugestión por parte del sujeto, con tendencia a aceptar las sugestiones

ofrecidas, debido a la presencia de un estado ambiguamente llamado "trance".

Weitzenhoffer (1989), también resalta la centralidad del papel de la sugestión en la hipnosis: "La hipnosis es un hipotético estado psicofisiológico caracterizado por la hipersugestionabilidad (sugestionabilidad elevada) del sujeto hipnotizado".

PROCESO DE HIPNOSIS



<http://axis-online.net/hypno/>

DIPLOMADO

2.1.2. ESTADO SUBJETIVO DE EXPERIENCIA

Los primeros practicantes de la hipnosis argüían un estado de trance en el que el sujeto perdía o reducía la potencia de su mente lógica y consciente, perdiendo su facultad crítica. De alguna forma en la actualidad se considera que el individuo hipnotizado es capaz de ser más creativo o imaginativo porque las constricciones impuestas por la mente "lógica" están minimizadas. De ello se sigue que cuando la mente lógica se reduce, la "razón" ya no constriñe la toma de decisiones y el individuo es más "creativo" y "sugestionable" que de ordinario (Hawkins, 1998).

Estas características implican en particular una alteración en los procesos lingüísticos. Las palabras, en la lógica del trance, se interpretan de modo mucho más literal, la comunicación se hace expresa

mediante la focalización en las palabras mismas más que en las ideas. Existe a su vez una disminución asociada del juicio crítico a la hora de procesar el lenguaje y un incremento de la tolerancia a la incongruencia (Hawkins, 1998).

Yapko (1990) en su definición de hipnosis resalta las características del estado de "trance": "un estado de relajación, hipersugestionable, estado de relajación mental y corporal y subsecuentemente más sensible a la sugestión", "Un estado de crepúsculo, a mitad de camino entre el sueño y el estado de vigilia", "un estado subjetivo de experiencia ("en hipnosis") en el que el individuo tiene capacidades o experiencias generalmente consideradas como atípicas del estado "normal de vigilia".

2.1.3. ATENCIÓN FOCALIZADA Y ABSORCIÓN EN EL PROCESO

El papel de la atención y la concentración en los procesos hipnóticos ha sido puesto de manifiesto en la mayoría de las conceptualizaciones teóricas.

Yapko (1990): "El trance es un estado de atención focalizada, dirigida interiormente o exteriormente". Waxman (1986) enfatiza la concentración sobre la voz del terapeuta: "La hipnosis puede ser definida como un estado alterado de consciencia producido por una total concentración en la voz del terapeuta; dando como resultado cambios mensurables a nivel físico, neurofisiológico y psicológico que pueden producir distorsiones en la emoción, sensación, percepción y la imagen".

Al observar atentamente un individuo hipnotizado podemos percibir claramente que el estado que presenta constituye un estado de concentración profunda. Nos parece que la consciencia enfocara su atención en puntos concretos (un sonido, la voz del terapeuta, la música, un punto brillante, etc.), aislándose del resto. Para entender mejor el proceso nos serviría utilizar la metáfora de la lupa: la energía se concentra sobre un punto concreto, pero sin perderse un ápice de ella. En hipnosis, el proceso de inducción (que conoceremos más adelante) se

constituye con el "rapto" de la atención del sujeto; atraer su atención y fijarla en un elemento del entorno o de sí mismo (externo o interno) prosiguiendo con nuevas instrucciones ritualizadas de profundización.

2.1.4. DISOCIACIÓN

Para algunos autores durante el trance hipnótico se produce una "consciencia paralela" definiéndose la disociación como "la capacidad para romper una experiencia global en sus componentes, amplificando la conciencia de una parte mientras disminuye la conciencia de otras" (Yapko, 1990).

Para Erickson la disociación está íntimamente relacionada con la inducción hipnótica sirviendo además como una forma de profundizar el trance, aunque de sus escritos cabe reducir que el trance no siempre entraña una disociación. El término de disociación en Erickson implica una rotura de las asociaciones mentales, siendo más correctamente una "disociación", como cuando una persona tiene la

sensación de que una parte de su cuerpo se separa percibiéndola como un objeto (en la levitación del brazo).

La disociación en hipnosis cobraría una dimensión especial, estableciéndose como "separación", "escisión", "división", etc. en los procesos mentales que normalmente se consideran unidos entre sí. Y también cuando algunos actos o conductas se producen al margen (o fuera de) la conciencia del sujeto, o bajo un control indirecto.

Actualmente, desde una perspectiva científica, lo que era considerado “disociación” es absolutamente equiparable al concepto de percepción subjetiva de involuntariedad en la ejecución de determinadas conductas bajo hipnosis (automaticidad del comportamiento). Y es una percepción en tanto que el sujeto es quien voluntariamente realiza una determinada acción o comportamiento, aun cuando perciba dicha acción o comportamiento como involuntario (por ejemplo, en el ejercicio de levitación del brazo).

2.1.5. LA LÓGICA DEL TRANCE

Este concepto fue acuñado por Orne (1959) conectado con lo que anteriormente referíamos en torno a la disociación. Orne hacía referencia a la capacidad de un sujeto, profundamente hipnotizado, para mantener su atención dirigida simultáneamente hacia cuestiones, percepciones o ideas inconsistentes desde un punto de vista puramente lógico. Para Orne, las alucinaciones (tanto las positivas como las negativas) son una buena muestra de "lógica del trance", del lenguaje simbólico y/o estructural que dotado de su propia idiosincrasia subyace durante el proceso hipnótico.

2.2. ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE LA HIPNOSIS.

Se han propuesto teorías e hipótesis explicativas diversas. Por ejemplo, Crasilneck y Hall (1985) o a Kroger (1977). Las teorías psicoanalíticas han identificado a la hipnosis con procesos transferenciales, fenómenos histéricos y regresiones infantiles provocadas. Las teorías neurofisiológicas se

centran en la relación entre hipnosis y sueño y el recurso a la fisiología para explicar los estados hipnóticos (inhibición cortical, cambios bioquímicos, neurotransmisores y neuromoduladores, dominancia del hemisferio derecho, etc.). Las teorías psicofisiológicas se centran en las relaciones entre la hipnosis y respuestas psicofisiológicas. Las teorías psicosociales hacen hincapié en el papel de las expectativas y la motivación, y la psicología del aprendizaje para explicar los fenómenos hipnóticos.

Pero en general todas las teorías pueden dividirse en dos grandes clases: teorías del estado versus teorías del no estado y teorías fisiológicas versus teorías psicológicas.

Las teorías del estado sobre la hipnosis suponen que el estado de trance es cualitativamente diferente de otras experiencias mentales humanas. Desde este punto de vista la capacidad hipnótica o capacidad para el trance es una especie de rasgo relativamente estable que muestra fuertes diferencias individuales.

Por otra parte, los teóricos del no estado consideran

que los fenómenos hipnóticos provienen de características psicológicas y sociales tales como la motivación, las expectativas de entrar en trance, la creencia y la fe en el hipnotizador, el deseo de agradarle y una experiencia positiva con el trance inicial.

Algunas teorías de la hipnosis tratan de describir el fenómeno en términos de actividad cerebral, mientras que otras, se concentran más en la experiencia fenomenológica. En cualquier caso la distinción fundamental está entre las teorías de hipnosis de El estado y el No estado

Los detractores de El estado creen que parte del núcleo de una hipnosis es el estado de conciencia, mientras que, los detractores del No estado creen que hay un proceso psicológico más mundano, porque la atención enfocada y la expectación son suficientes para explicar el fenómeno hipnótico.

La definición precisa de qué constituye un estado de conciencia alterado es tema de debate. Aunque algunas personas hipnotizadas describen su

experiencia como de alterada, es difícil usar estos
términos para describir la experiencia de una persona en trance.

TRANCE



RRR/22

ULTPERÚ
OMADO

2.2.1. TEORÍAS DE DISOCIACIÓN Y NEODISOCIACIÓN

Pierre Janet desarrolló originalmente la idea de la disociación, literalmente como la separación de algunos componentes de la conciencia, como resultado de su trabajo con pacientes histéricos. Creía que la hipnosis era resultado de la disociación: las áreas del control del comportamiento de un individuo están separadas del comportamiento ordinario. En este caso, la hipnosis quitaría algo de control de la mente consciente y el individuo respondería con un comportamiento autónomo y reflexivo.

2.2.2. TEORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL / TEORÍA DEL ROL

Esta teoría sugiere que los individuos adquieran un rol y así permiten al hipnotizador crear una realidad para ellos. Esta relación depende de cuanta

narración se haya establecido entre el hipnotizador y el sujeto. Generalmente bajo la hipnosis la gente se vuelve más receptiva a la sugestión, causando cambios en la forma en que se sienten, piensan y se comportan. Algunos psicólogos han sugerido que la hipnosis es una traducción literal, tan bien conocida que las expectativas sociales son llevadas a cabo por sujetos, quienes creen estar en un estado de hipnosis, comportándose de la manera en que ellos se imaginan que se comporta un hipnotizado. Mucho trabajo experimental ha demostrado que las experiencias de los sujetos hipnotizados pueden ser dramáticamente formadas por expectativas y matices sociales. Este punto de vista normalmente se malentiende: No descuenta la afirmación de que los individuos hipnotizados están realmente experimentando efectos de sugestión, tan solo que los mecanismos por los cuales se lleva a cabo esta acción están en parte contruidos socialmente y que no necesariamente se confie en la idea de un estado de conciencia alterada.

2.2.3. HIPÓTESIS DE NICOLÁS SPANOS

Nicholas Spanos hipotetizó que los comportamientos asociados con la hipnosis se hacen con conocimiento de la persona. Alegó que había dos razones por las cuales las personas confunden su estado de conciencia por hipnosis. Siendo una de las causas que la misma gente cree que su comportamiento está causado por una fuente externa en vez de por ellos mismos. La segunda está relacionada con los rituales llevados a cabo por la hipnosis. El hipnotista dice ciertas cosas las cuales son primariamente interpretadas como voluntarias y más tarde en el procedimiento como involuntarias. Como ejemplo “Relaja los músculos de las piernas” y después “Tus piernas están blandas y pesadas”. Los descubrimientos de “Spanos” no eran para demostrar que el estado de hipnosis no existe en absoluto sino para demostrar que los comportamientos exhibidos por esos individuos se deben a individuos “altamente motivados”.

2.2.4. HIPNOSIS COMO PROCESO CONDICIONADO INDUCIENDO A DORMIR

Ivan Pavlov creía que la hipnosis era un sueño parcial. Observó que los varios grados de hipnosis no diferían perceptible y fisiológicamente del estado de despertar y que la hipnosis dependía de insignificantes cambios de estímulos ambientales. Pavlov también sugirió que los mecanismos más bajos del cerebro, estaban envueltos en condición hipnótica. Algunos bienes conocidos y modernos hipnoterapeutas se anexan a esta teoría desde que en hipnosis el sujeto parece típicamente estar dormido por tener los ojos cerrados que típicamente es parte del procedimiento de inducción. Sin embargo hay bastante literatura en estudios de la presión arterial, de los reflejos, estudios fisicoquímicos y de EEG que indican que la hipnosis se asemeja más a estar completamente despierto.

2.2.5. TEORÍA DE LA HIPER-SUGESTIBILIDAD

Actualmente una teoría más popular se basa en que la atención del sujeto está estrechada por ciertas técnicas usadas por el hipnotizador. Como la atención del sujeto se estrecha, las palabras del hipnotizador eventualmente se sobre imponen sobre la voz interior del sujeto. De esta teoría viene la implicación de que solamente mentes débiles son sugestionables.

2.2.6. TEORÍA INFORMACIONAL

Esta teoría aplica el concepto del modelo del cerebro como computadora. Los sistemas electrónicos, ajustan sus redes de regeneración para aumentar el cociente señal-ruido para el funcionamiento óptimo, llamado estado constante. Aumentando la receptabilidad de un receptor permite que los mensajes se reciban con más claridad desde un transmisor, sobre todo intentando reducir la interferencia (ruido) tanto como sea posible. Así, el objetivo del hipnotizador consiste en utilizar técnicas

para reducir la interferencia y aumentar la receptabilidad de mensajes específicos (sugestiones).

2.2.7. ESTADO DE HISTERIA

Charcot postuló que la hipnosis era un síntoma de histeria y que solamente las personas que la experimentan se las cree hipnotizables. Aunque los susceptibles a padecer histeria parecen más sugestionables, las personas normales son profundamente hipnotizables, lo cual suscita controversia.

2.2.8. INVESTIGACIÓN DE LA HIPNOSIS

Se ha llevado a cabo suficiente investigación sobre la naturaleza de los efectos de la hipnosis y la sugestión y ambas continúan siendo una herramienta contemporánea en la investigación psicológica. Un número de diversos filamentos son aparentes:

Los que examinan el estado de hipnosis por sí mismo.

Los que examinan de adentro afuera los efectos y propiedades de las sugerencias de la hipnosis.

Y los que usan la sugestión hipnótica como herramienta para investigar

Otras áreas de funcionamiento psicológico.

Con el reciente advenimiento de nuevas técnicas de proyección de imagen del cerebro ha habido un resurgimiento de interés en la relación entre la hipnosis y el funcionamiento del cerebro. Cualquier experiencia humana se refleja de cierta manera en los colores que el cerebro ve o por el movimiento subrayado por la actividad en la corteza visual, el sentimiento de temor es mediado por la actividad en la amígdala de modo que la hipnosis y la sugestión tengan efectos observables sobre la función del cerebro. Una edición importante para los investigadores que llevan a cabo proyección de imagen del cerebro es separar los efectos de la hipnosis y de la sugestión, sabiendo que una sugestión dada durante la hipnosis afecte el área X del cerebro no nos dice solo sobre la hipnosis, nos

dice también sobre los efectos de la sugestión. Para explicar esto, los experimentos necesitan incluir una no-hipnótico-respuesta-a-sugerencia.

Sólo de éste modo pueden examinarse los efectos específicos de la hipnosis. Se ha llevado a cabo un número de estudios de proyección cerebral de imagen mientras los sujetos se encontraban bajo hipnosis. Una selección de éstos estudios se explica aquí abajo:

Un experimento científico controlado postula que la hipnosis puede alterar la percepción y opinión de nuestra experiencia de conciencia de un modo que no es posible cuando la gente no está hipnotizada, al menos en gente altamente hipnotizable. En este experimento, la percepción del color cambiaba por la hipnosis en gente altamente hipnotizable.

La Hipnosis, como forma de conducta natural ha existido desde los orígenes mismos de la humanidad, con diferentes nombres a través de los tiempos, por cierto, pero siendo siempre un mismo fenómeno psiconeurofisiológico. Hoy es entendida la hipnosis

cognitiva como un modo, un estilo comunicación a un estado de receptividad específico y como una predisposición cognitiva a utilizar y optimizar los propios potenciales que cada persona posee.

La hipnosis, para muchos, parece tener una finalidad muy simplificadora de ese arte o técnica que es la psicoterapia. Esta sobre simplificación es un grave error que en mucho perjudica a la hipnología.

III CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO HIPNÓTICO

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO HIPNÓTICO

Para una revisión de estas características, tendremos en cuenta las investigaciones españolas de Miguel Tobal y González Ordí en el año de 1988:

3.1.1. Aumento de la sugestionabilidad (hipersugestionabilidad).

Para algunos autores esta es una de las características principales del estado hipnótico: el empleo de sugerencias adecuadas y dirigidas a provocar cambios cognitivos, fisiológicos o

comportamentales en el individuo debido a que éste se encuentra en una actitud más receptiva.

3.1.2. Aumento de la capacidad de imaginaria mental.

Muchos de los procedimientos derivados del marco terapéutico cognitivo conductual se llevan a cabo mediante el uso de estrategias basadas en la imaginación y la visualización. La hipnosis ha empleado las técnicas imaginativas para inducir estados emocionales concretos, para aumentar la responsabilidad del sujeto hipnótico o con intervenciones terapéuticas centradas en metáforas relacionadas con el sujeto o con los problemas emocionales del sujeto hipnotizado o simplemente mediante un empleo similar al utilizado por psicólogos cognitivo conductuales al margen de procedimientos hipnosuggestivos. Está fuera de toda duda que la hipnosis incrementa la capacidad imaginativa y de visualización del sujeto.

3.1.3. Aumento de la implicación emocional sugeridas directamente por el experimentador.

El sujeto hipnotizado experimenta las imágenes sugeridas por el hipnotizador como si fueran reales. La implicación emocional que se deriva de los procedimientos hipnóticos es uno de los factores que promueven el cambio terapéutico sin lugar a dudas. Mediante la hipnosis cabe optimizar y catalizar las técnicas de visualización y los beneficios de tratamientos derivados del empleo de la imaginación.

3.1.4. Focalización de la atención a una situación estimular restringida.

La restricción sensorial y la estimulación repetitiva (procedimientos estándares de inducción hipnótica) promueven la focalización de la atención del sujeto hipnotizado hacia elementos discretos sugeridos por el terapeuta y hacia las verbalizaciones de este.

3.1.5. Distorsión de las variables psicológicas de espacio y tiempo.

La restricción sensorial y la progresiva focalización de la atención conllevan para el individuo hipnotizado la pérdida de claves de referencia espacio-temporales, lo que origina distorsión subjetiva en la medición e interpretación de dichas variables.

3.1.6. Automaticidad del comportamiento.

Spanos (1982) habla de la importancia del concepto de involuntariedad (o automaticidad del comportamiento), relacionado con el anteriormente comentado de "disociación". No implica necesariamente un estado alterado de conciencia, sino una interpretación diferente a nivel estimular y sensorial de un hecho observable. Cuando en un procedimiento de "catalepsia del brazo" el sujeto interpreta como involuntario la experiencia conductual en la que se halla implicado lo que hace es interpretar de un modo particular un hecho objetivo; asimismo su interpretación se halla influida

y facilitada por lo que el individuo cree sobre el fenómeno.

3.1.7. Disminución de la capacidad de análisis lógico-racional.

Donde especifica el término "lógica del trance".

3.1.8. Sensación de relajación profunda.

Aunque tradicionalmente se ha pensado que la hipnosis producía una relajación profunda, estudios recientes parecen demostrar que no necesariamente ha de existir una relación directa entre relajación como sensación subjetiva y relajación desde el punto de vista de la reducción fisiológico. En este sentido, la hipnosis parece influir más sobre los aspectos subjetivos que sobre los fisiológicos, siempre y cuando no se empleen sugerencias específicas para modificar éstos últimos.

3.1.9. Alteraciones psicofisiológicas.

En la aplicación de hipnosis neutral (sin sugerencias adicionales) parecen hallarse patrones de activación

psicofisiológica encontrados en técnicas clásicas de reducción de ansiedad (relajación, meditación, entrenamiento autógeno). Sin embargo, cuando se añaden sugerencias específicas de cambio de determinadas respuestas psicofisiológicas, parece ser que el patrón de respuesta es modificado en la dirección planteada por dichas sugerencias.

Tales características evidencian el papel que la hipnosis puede jugar en la terapia cognitivo-conductual, pues todas ellas pueden condicionar positivamente los resultados de cualquier aplicación psicológica. El aumento de sugestionabilidad, el incremento cualitativo y cuantitativo de la producción imaginativa, la implicación emocional, la focalización de la atención del paciente y la sensación de relajación profunda son las que se muestran más interesantes y destacadas en lo que a la clínica se refiere.

3.2. COMPONENTES DEL TRANCE HIPNÓTICO

El estado hipnótico es un estado alterado de consciencia. Se caracteriza por una reacción

emocional intensificada y por una alta concentración selectiva. Esto es lo que se llama "trance". Algunas corrientes en hipnotismo eluden el término trance, pero lo definen exactamente igual. Es cuestión de definiciones y, a veces, de querer marcar cierta singularidad por asuntos de marketing.

3.2.1. Seguridad.

El sujeto se siente seguro, con confianza y protegido. La sesión lo deja en un estado de bienestar y seguridad, disminuyendo los sentimientos negativos consigo mismo.

3.2.2. Relajación Psicofísica.

El sujeto se siente muy relajado a tal punto que le gustaría permanecer en estado de trance.

3.2.3. Concentración relajada.

La mente consciente se va enfocando cada vez más en una sola imagen o idea, de manera tranquila y relajada.

3.2.4. Receptividad.

El sujeto no hace nada, simplemente se deja llevar y deja a su poderosa mente interior actuar.

3.2.5. Recuerdo.

El estado de trance permite acceder a información que había estado olvidada en la mente. Es posible acceder al pasado y liberarse de los efectos negativos de sentimientos y recuerdos reprimidos.

3.2.6. Hipersugestibilidad.

Al estar la consciencia centrada en un solo punto, los mensajes penetran al fondo mental, impregnándolo e impresionándolo. Esto permite modificar sus impulsos y tendencias, evitando la inseguridad y duda de la consciencia.

3.2.7. Refuerzo.

Con instrucciones adecuadas, la hipnosis tiene efectos después del viaje o sesión, evitando la resistencia al cambio y formando nuevos hábitos.

3.2.8. Consciencia paralela.

Es posible ser consciente que se encuentra aquí en la sesión y a la vez en otro lugar del tiempo y del espacio. Esta situación de la consciencia permite también extraer información e ideas de muy difícil acceso en el estado habitual.

3.2.9. Olvido selectivo.

La mente puede decidir olvidar lo recordado o realizado en la sesión si considera que no es necesario mantener la mente en ello y que debe centrarse en lo realmente importante.

Muchas veces puede sentirse temor de recordar algo que no se está capacitado para afrontar. Pero la mente tiene poderosos mecanismos de defensa y el inconsciente sólo deja pasar los pensamientos que pueda manejar la mente consciente.

3.2.10. Actitud Mental Positiva.

La hipnosis desarrolla la positividad, permitiendo al sujeto cambiar favorablemente su destino y protegiéndolo de las negatividades interna y externa.

Escala de Davis Y husband. Encuentra aquí información detallada, para despejar todas tus dudas respecto a la antigua practica de la hipnosis,

e
r
t

SITUACIÓN HIPNÓTICA	PUNTUACIÓN	EFECTOS OBSERVABLES
------------------------	------------	------------------------

é

r

a

t

e de lo más importante sobre la Escala de Davis Y husband.

Se puede decir que las clasificaciones referidas a los signos que se observan durante el trance hipnótico, son innumerables.

Signos característicos que van apareciendo a medida que el denominado proceso hipnótico avanza y permiten sacar conclusiones del nivel de profundidad al que se ha llegado. Una de las clasificaciones más conocidas es la de Davis y Husband, en la que se señala la sucesión de efectos durante la hipnosis:

Refractaria Inducción	0	
	2	Relajación
	3	Pestañeo
	4	Cierre ocular
	5	Relajación física completa
Ligera	6	Catalepsia
	7	ocular
	10	Catalepsia de
	11	miembro
		Catalepsia rígida
Media		Anestesia (en guante)
	13	Amnesia parcial
	15	Anestesia post-hipnótica
	17	
	18	Cambios de personalidad
	20	Sugestiones

		post-hipnóticas simples Alucinaciones cinestésicas y amnesia completa
Profunda	21 23 25 26	Capacidad de abrir los ojos sin interrumpir el proceso Sugestiones post-hipnóticas de naturaleza fantástica Sonambulismo completo Aceptación de sugestiones post-hipnóticas y de

		alucinaciones visuales positivas
--	--	--

IV MÉTODOS, ESTADO Y UTILIDADES EN LA HIPNOSIS ERICKSONIANA

4.1. MÉTODOS DE LA HIPNOSIS ERICKSONIANA.

Existen muchos métodos de inducción. Incluso podemos inventarnos variantes adecuadas o adaptadas al sujeto que se ha de someter al trance, tal y como hacía en muchas ocasiones el Dr. Milton Erickson, que usaba en muchos de sus “diálogos hipnóticos” metáforas, situaciones imaginarias, historias y cuentos, etc. Exponemos aquí algunos muy usados.

4.1.1. MÉTODO DE INDUCCIÓN ORAL.

Quizás sea largo, pero es bastante seguro a la hora de obtener resultados. El sujeto puede estar sentado o tumbado. En todo caso en una posición cómoda. Preferiblemente con los ojos cerrados le iremos induciendo con nuestra voz relajando parte a parte del cuerpo, empezando por los pies y acabando por la cabeza o viceversa. Al terminar esta relajación

progresiva vamos introduciendo sugerencias de pasividad y sueño: Ahora te encuentras tan a gusto que dormirás... sientes como un ensueño agradable te va envolviendo...”

4.1.2. MÉTODOS DE FIJACIÓN DE LA MIRADA.

Son todos aquellos en que indicamos a un sujeto que se fije en cualquier cosa exterior, bien fija, con movimiento. Puede tratarse de un foco de luz, un péndulo oscilante, un disco hipnoidal. Antes o después incluso sin sugerencias por parte del hipnólogo se irá produciendo un cansancio ocular que nos irá adormeciendo. Si introducimos sugerencias serán de este tipo: “Conforme miras este objeto, tus ojos van sintiendo un ligero cansancio que cada vez se hace más intenso. Poco a poco los párpados se vuelven más pesados y es como si quisieras cerrar los ojos porque quieres dormir o descansar...”

4.1.3. MÉTODO DE LA CATALEPSIA

Pedimos al sujeto que una con fuerza sus piernas y que apriete los brazos estirados hacia el cuerpo, que ponga rígidos todos los músculos de su cuerpo, que apriete el abdomen y en definitiva, que se imagine que una especie de tabla o estatua de bronce. Acto seguido la imprimiremos un ligero balanceo para que note su rigidez. Una vez conseguida la rigidez total, podemos con ayuda de otras personas, tumbarle en el suelo, en un diván o camilla. Inmediatamente le indicaremos que se encuentra muy concentrado y que dormirá o entrará en un estado profundo y especial a nuestra indicación. Podemos dar un pequeño chasquido con los dedos o tocarle ligeramente la frente con los dedos al mismo tiempo que decimos: ¡duerme! o ¡Ya está... estas en un estado profundo y especial! A partir de ahí, usamos sugerencias para profundizar.

4.1.4. MÉTODO DE LA RIGIDEZ DEL BRAZO.

La persona está sentada... le estiramos el brazo y lo colocamos a la altura del hombro.

Le sugerimos que se encuentra bien y que su brazo cada vez está más rígido. Le hacemos sentir con ligeras presiones sobre la mano dicha rigidez para que se retroalimente en la sugestión... una vez conseguido le indicamos que el brazo comenzará a pesar, que se ha transformado en plomo...” el brazo en tan pesado que se peso se hace insostenible e irá cayendo. Conforme el brazo va bajando, notarás como un sueño agradable e intenso te va invadiendo... cuando el brazo se desplome por completo, dormirás. Si la sugestión surte efecto, el sujeto irá bajando el brazo hasta soltarlo por completo; en este momento daremos la orden ¡duerme!

4.1.5. MÉTODO DE LA EXPECTACIÓN

Especialmente cuando se hace hipnosis de espectáculo, este método es útil. Supongamos un aforo donde se espera al hipnotizador con expectación... por tanto ya existe un ambiente lo suficientemente sugestivo para inducir con facilidad

a cualquier asistente. El hipnotizador deberá hablar con cierto misterio y persuasión. Al acercarse a cualquier espectador que ponga reparos a su proximidad ante el temor de ser hipnotizado, a un solo toque u orden del inductor, entrará con facilidad en hipnosis.

4.1.6. MÉTODO DEL “ENGAÑO”

Especialmente para usarlo con sujetos difíciles. Pondremos a una persona ante nosotros indicándole que le vamos a hipnotizar (le habremos comentado previamente que en realidad no será a ella a quien induciremos, sino que simplemente debe fingir que está durmiendo); a su lado pondremos a otra a la que realmente queremos inducir y explicaremos que su misión es observar con todo el detalle y atención que pueda cómo se duerme la otra persona. Preferiblemente podremos a uno frente a otro y el inductor se sitúa en medio. Bien... llegado este punto a nuestro compinche le pasaremos un péndulo

oscilando por delante de los ojos, por ejemplo y el comenzará a fingir su adormecimiento. Deberemos estar atentos a nuestra verdadera víctima, pues cuando su atención sea intensa, soltaremos de una el péndulo y de inmediato sin darle tiempo y reaccionar, situaremos nuestra mano delante de su frente o sus ojos cerrándoselos y diciéndole enérgicamente: ¡duerme!

Una puntualización a tener en cuenta es que muchas personas son reacias ante términos como “hipnosis” “hipnotismo” o “sueño” por el temor que estos suscitan de pérdida de la propia conciencia. En ese caso podemos sustituirlos por palabras o expresiones como “estado especial” “trance” “ensueño” “sopor” etc.

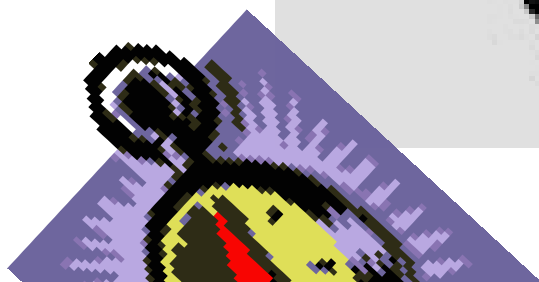
4.2. ESTADOS EN LA HIPNOSIS

Son diversos los autores, investigadores y terapeutas que han establecido diferentes escalas en el grado de profundidad hipnótica. Estas divisiones son por tanto subjetivas y de orientación. La escala más extendida y sencilla por su comprensión es la que divide la progresión hacia la hipnosis profunda en tres grados, como la que presentó Charcot en la Academia de Medicina de París cuando elaboró su informe sobre la hipnosis. El hablaba de los grados letárgico, cataléptico y sonambólico.

MATERIALES



RRR/22



4.2.1. REACCIONES EN EL HIPNOTIZADO

b. PRIMER GRADO - ESTADO LETÁRGICO

El sujeto tiene su atención concentrada. La respiración es lenta y tranquila.

Si los ojos están abiertos, puede aparecer parpadeo rápido hasta que se cierran. Si el lugar no está suficientemente caldeado, el sujeto puede sentir frío.

La tensión arterial puede bajar ligeramente debido a la relajación. Existe sensación de pesadez en el cuerpo, especialmente en los miembros. Todos los músculos se relajan progresivamente y aparecen en consecuencia una sensación de agradable entumecimiento.

c. SEGUNDO GRADO - ESTADO CATALÉPTICO

La respiración es más lenta y profunda (abdominal). La cabeza puede caerse ligeramente por la relajación del cuello.

Podemos producir rigidez en todo el cuerpo o en sus partes. Si el sujeto habla, su tono de voz es lento y adormecido.

Sensación de profundo bienestar. El paciente admite ya las primeras sugestiones y aunque se percate de ellas, le resulta muy difícil sustraerse a las mismas.

Podemos producir insensibilidad al dolor. Sin embargo aún existe consciencia suficiente para que la sujeta

salga de este estado si lo desea. Se va perdiendo la noción del exterior.

d.ERCER GRADO - ESTADO SONAMBÚLICO

El sujeto está completamente pasivo. Pero al sugerirle sensaciones o situaciones, puede abrir los ojos, moverse, hablar o realizar cualquier cosa igual que si estuviera en estado de vigilia normal, sin salir ya del trance hipnótico. Cualquier comportamiento sugerido, es aceptado y manifestado inmediatamente como algo real que le sucede.

Podemos inducir la amnesia post hipnótica. (Que el sujeto no recuerde nada cuando despierte).

El sujeto está muy aislado del exterior; se encuentra muy a gusto. El mayor estímulo externo que le hace reaccionar son las sugerencias del hipnólogo. Puede darse amnesia post-hipnótica espontánea. Las sugerencias son aceptadas sin ninguna oposición y en esta fase es donde tienen su mayor efectividad. Las funciones inconscientes se manifiestan sin apenas dificultad, por lo que se podrían dar fenómenos

paranormales, como por ejemplo: telepatía, xenoglosia, precognición, clarividencia. El estudio en hipnosis regresiva y a vidas pasadas, debe hacerse en este trance.

4.3. UTILIDADES DE LA HIPNOSIS

En general, tanto la hipnosis como el resto de técnicas psicofísicas pueden emplearse en cualquier campo de la actividad humana con mayor o menos intensidad. Pero exponemos aquí los campos en los que más incidencia tiene.

4.3.1. MEDICINA

- * Producir insensibilidad al dolor (anestesia)
- * Eliminar o atenuar todo tipo de dolores o molestias
- * Mejorar la efectividad del sistema inmunitario.
- * Mejorar cualquier enfermedad en general.
- * Especial uso en dermatología, donde se eliminan con facilidad eczemas, verrugas o erupciones cutáneas.

4.3.2. PSICOLOGÍA

- * Tratamiento de todos los trastornos mentales.
- * Timidez, enuresis, fobias (agorafobia, claustrofobia, miedo a los animales, etc), adicciones (tabaquismo, ludopatía, alcoholismo...)
- * Indecisión, falta de concentración, estrés, depresión, angustia, tartamudez...
- * Mejorar las relaciones sociales...

4.3.3. EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA

- * Mejorar el rendimiento escolar
- * Mejorar la memoria y acrecentar la asimilación al estudiar
- * Estimular las capacidades creativas.
- * Incrementar la capacidad de comprensión y asimilación.
- * Motivar para el estudio, incluso de aquellas asignaturas que se “resisten”

4.3.4. ECONOMÍA, EMPRESA, VENTAS

- * Mejorar los dones de convicción

- * Estimular la capacidad para crear estrategias.
- * Adquirir conocimientos para convencer más y mejor a los clientes.
- * Trabajar en equipo con eficacia.

4.3.5. POLÍTICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL.

- * Comunicación de masas
- * Sugestión colectiva.
- * Técnicas de comunicación social

4.3.6. DEPORTE

- * Incrementar la resistencia
- * Desarrollar los reflejos y la rapidez
- * Aumentar la concentración durante competiciones o ejercicios.
- * Desarrollar la capacidad física total del cuerpo.
- * Coordinar óptimamente la relación pensamiento-movimiento.
- * Aumentar la fuerza física.
- * Aumentar la motivación.

BIBLIOGRAFIA

- **AUER H. : PSICOLOGÍA HUMANISTICA UNIFE
LIMA 1990**
- **WELTZENHOFFER ANDRÉ: TECNICAS
GENERALES DE HIPNOTISMO EDITORIAL
PAIDOS BUENOS AIRES 1964**
- **PACHECO LEON MARIO : SEMINARIO
DIDACTICO DE MILTON ERICSSON
.RECOPIACION EN VERSION ESPAÑOLA
1984**
- **ETZEL CARDEÑA Y COL : LA HIPNOSIS Y
TRASTORNOS POSTRAUMATICOS
,PUBLICACIÓN DE UNI DE MURCIA 1999**